2.1.2.2. 정신건강의학과 · 소아정신과 입원환자 관리

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	정신건강의학과, 소아정신과, 입원원무팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 정신의료기관평가기준: 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 3.1.3 JCI Standard 7th Edition: ACC.1, PCC.1.5, AOP.1.6, COP.3, 3.5

제1조 (목적)

1. 정신건강의학과 · 소아정신과 입원치료가 필요한 환자에게 적시에 진료를 제공하기 위해 표준화된 절차를 제공하고 준수하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 정신과적 응급상황: 정신과적 질환이 급성기 상태로 발현하거나 악화되어 환자 본인 혹은 타인의 안전과 건강에 위협이 되는 상황으로 자살, 자해, 폭언, 폭행, 기물파손 등이 이에 해당한다.
2. 치료 프로그램: 환자의 증상을 조절하고 적응 기능을 향상시키며 원활한 사회 생활 참여 유도를 위한 프로그램으로 인지행동치료, 사회기술훈련 등이 포함된다.
3. 소아청소년 환자: 만 18세 이하(만 19세 미만)의 소아, 청소년 환자

제3조 (절차)

1. 정신과적 치료환경 관리
   1) 병동 내 위해물품 목록 및 관리
      (1) 병동 내 위해도구
         ① 병동 내 위해도구는 환자의 안전을 위해 병동 내에서 보관하고 있는 물품 중 관리가 필요한 위해도구를 말한다.
         ② 긴 끈류(보호대, 수동혈압계), 날카롭고 끝이 예리한 물건(스테이플러, 연필깎이, 테이프 커터기), 화학물질(손소독제) 등을 포함한다.
      (2) 병동 내 반입 제한 물품
         ① 반입 제한 물품 목록은 화재 위험 및 흡연 관련 물품, 유리 및 스테인리스 제품, 날카롭고 끝이 예리한 물건, 긴 끈, 화학물질, 이외 의료진의 회의를 통해 환자에게 위험성이 있다고 판단되는 물품 등을 포함한다.
   2) 위해도구 관리
      (1) [부록1. 병동 내 위해도구 점검일지]를 통하여 매일 수량을 확인하고 정해진 장소에 보관되어 있는지 점검한다.
   3) 반입 제한 물품 관리
      (1) 입원 시 환자 및 보호자에게 반입 제한 물품에 대한 반입금지 협조와 사물검사 시행에 대하여 안내하고 게시한다.

(2) 입원 시, 이후 주 1회 정기적으로 [부록2. 환자 및 보호자 물품 검사 현황]에 따라 반입제한물품에 대한 검사를 시행하여 안전사고 예방점검을 한다.

(3) 확인되는 반입제한물품은 병동에서 관리하는 사물함에 보관하거나 보호자에게 전달하여 반입을 제한한다.

(4) 자살, 자해 위험이 높은 환자는 세브란스병원 내규 [3.2.6.1. 자살 또는 자해 위험 관리] 위험도 구분에 따라 물품검사를 실시한다.

① 고위험군: 매일 물품검사 시행

② 중등도 위험군: 격일로 물품검사 시행

4) 안전사고 예방점검

(1) 산책, 외출/외박, 면회 등 수시 출입 시 보안요원이 출입구에서 위해물품이 반입이 되지 않도록 점검, 관리한다.

(2) 위해물품이 발견되었을 때 환자 및 보호자에게 해당 물품의 위험성에 대해서 설명 후 즉시 수거한다.

(3) 위해물품 외에 환자에게 위해가 될 수 있는 병동 시설 및 환경에 대해 주 1회 점검을 시행하여 필요 시 적절한 조치를 취한다.

2. 정신과적 응급상황 관리

1) 정신과적 고위험환자(자살, 자해, 타해, 폭력 등) 관리

(1) 환자 상태 평가 시행 시점: 입원 시 환자상태를 평가하고 최소 1일 1회, 환자상태 변화 시 재평가를 시행하여 자살, 자해, 타해, 폭력 등의 위험 여부를 스크리닝한다.

(2) 관련 직원 간 고위험환자 정보공유

① 매주 1회 치료진 회의를 통해 고위험 환자 여부를 결정하고 관련 의료진에게 해당 정보를 제공하여 고위험 환자를 집중관찰 한다.

② 고위험 환자임을 의무 기록에 명시하여 관련 직원들이 이를 확인할 수 있도록 한다.

(3) 고위험환자 모니터링 및 기록: 정신건강의학과 의사는 입원 시, 재원 중 주 2회 이상 환자와 면담을 시행하며 폭력 가능성 점검, 자살 및 자해 위험성을 평가하고 이를 기록한다. 이를 위해 [부록3. 자살의 위험성 평가(SSS, Severance Suicide Scale)], [부록4. 자해의 위험성 평가(SDSHS, Severance Deliberate Self Harm Scale)] 등의 도구를 활용할 수 있다.

(4) 자해 및 타해 위험성이 높고 폭력 가능성이 높은 경우 필요시 주치의(담당교수) 지시하에 격리실로 격리 조치할 수 있다.

(5) 고위험 환자는 보호자가 24시간 상주하는 것을 원칙으로 한다.

(6) 정기적인 순회를 통해 시설 및 환경의 자살, 자해 위험성 등을 평가하고 관리한다.

(7) 환자의 자해, 타해 등 위험성 수준에 따라 개방병동 또는 보호병동의 적합성을 평가한다.

2) 정신과적 응급상황 발생 시 대처방안

(1) 직원 간 협력체계

① 필요 시 보안팀 및 내·외과 등의 타 부서의 업무 협조를 할 수 있다.

② 응급상황 발생 시 보고체계에 따라 보고하고 관련 직원들과 내용을 공유한다.

(2) 절차

① 정신건강의학과적 응급상황 발생 시 최초 목격자는 상황에 따라 처치를 실시한다.

② 환자 안전을 위협하는 사고가 발생되면 주치의(담당교수) 또는 담당의사(전공의)와 부서장에게 보고한다.

③ 필요 시 환자 또는 타 환자의 안전을 위해 격리, 강박 조치를 시행할 수 있다.

④ 본원에서의 의학적 조치가 불충분하여 전원을 고려해야하는 경우 세브란스병원 내규 [2.1.5.2. 회송(전원)]에 준하여 전원 여부를 결정하고 시행한다.

(3) 환자안전사건 보고 시행: 다음의 경우에 해당하는 정신과적 응급상황 발생 시 보고서를 작성하여 환자안전팀에 보고한다.

① 사건 발생(자해 및 자살시도, 타인에 대한 공격적 행동)으로 환자 혹은 타인이 일시적 손상을 입었으며, 그 결과 입원이 필요하거나 재원기간이 늘어난 경우

② 사건 발생(자해 및 자살시도, 타인에 대한 공격적 행동)으로 환자 혹은 타인이 영구적 손상을 입었거나 거의 죽음에 이르는 상태가 된 경우

3. 입원 수속 및 유지 관리

1) 입원 유형

(1) 자의입원: 자신의 의지에 따른 입원

(2) 동의입원: 본인의 입원의사와 보호의무자 1명의 입원 동의에 따른 입원

① 보호의무자는 정신질환자의 민법상의 부양의무자(직계혈족 및 그 배우자, 생계를 같이하는 친족) 또는 후견인이 될 수 있다.

② 피성년후견인 및 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 환자를 상대로 한 소송이 계속 중인 자 또는 소송한 사실이 있었던 자와 그 배우자, 미성년자, 행방불명자는 보호의무자가 될 수 없다.

③ 보호의무자는 보호하고 있는 정신질환자가 적정한 치료를 받도록 노력하고 자신 또는 타인을 해치지 아니하도록 유의하여야 하며, 정신건강의학과 전문의의 진단에 따라 정신질환자가 입·퇴원할 수 있도록 협조하여야 한다. 또한 보호의무자는 정신질환자의 재산 상의 이익 등 권리보호를 위하여 노력하여야 하며 환자를 유기해서는 안된다.

(3) 보호의무자에 의한 입원(보호입원): 정신건강의학과전문의가 입원등이 필요하다고 진단하고 보호의무자 2명 이상이 신청한 경우

① 환자의 법적 보호의무자 2인(보호의무자가 1명만 있는 경우에는 1명으로 한다)은 권리고지, 보호입원등 신청서를 작성한다.

② 입원을 하게 되면 보호입원등신청서를 작성한 보호의무자에게 입원 사유와 퇴원심사 등의 청구에 관한 사항을 서면 또는 전자문서로 통지한다.

③ 보호의무자는 정신질환자의 민법상의 부양의무자(직계혈족 및 그 배우자, 생계를 같이하는 친족) 또는 후견인이 될 수 있다.

④ 피성년후견인 및 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 환자를 상대로 한 소송이 계속 중인 자 또는 소송한 사실이 있었던 자와 그 배우자, 미성년자, 행방불명자는 보호의무자가 될 수 없다.

⑤ 보호의무자 사이의 보호의무의 순위는 부양의무자·후견인의 순위에 의하며

부양의무자가 2인 이상인 경우 보호의무자를 2인으로 정한다.

⑥ 보호의무자는 보호하고 있는 정신질환자가 적정한 치료를 받도록 노력하고 자신 또는 타인을 해치지 아니하도록 유의하여야 하며, 정신건강의학과 전문의의 진단에 따라 정신질환자가 입·퇴원할 수 있도록 협조하여야 한다. 또한 보호의무자는 정신질환자의 재산 상의 이익 등 권리보호를 위하여 노력하여야 하며 환자를 유기해서는 안된다.

(4) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 의한 입원(행정입원)

① 정신질환으로 자신 또는 타인의 건강 또는 안전에 해를 끼칠 위험이 있다고, 의심되는 자를 발견한 정신건강의학과 전문의 또는 정신건강 전문요원은 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에게 진단 및 보호를 신청할 수 있다.

② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장의 의뢰를 받은 정신건강의학과 전문의가 자신 또는 타인을 해할 위험이 있어 그 증상의 정확한 진단이 필요하다고 인정한 때는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장은 그 사람을 보건복지부장관이나 지방자치단체의 장이 지정한 정신의료기관에 2주 이내의 기간을 정하여 입원하게 할 수 있다. 정신의료기관의 장은 지체 없이 2명 이상의 정신건강의학과 전문의에게 그 사람의 증상을 진단하게 하고 그 결과를 특별자치시장·특별자치도지사·시장· 군수·구청장에게 서면으로 통지하여야 하며, 정신건강의학과 전문의 2인이 계속 입원이 필요하다는 일치된 진단을 내린 경우에만 그 정신질환자에 대하여 정신의료기관에 치료를 위한 입원을 의뢰할 수 있다. 입원을 하게 되면 환자 및 보호의무자 또는 보호를 하고 있는 사람에게 입원이 필요한 사유와 퇴원심사 등의 청구에 관한 사항을 서면 또는 전자문서로 통지한다.

③ 정신건강의학과 전문의 또는 정신건강전문요원은 진단 및 보호신청서를 작성하고, 정신건강의학과 전문의는 진단 결과를 진단결과서로 작성한다.

④ 2차 진단 등을 위한 타 기관 전문의 및 입원적합성심사위원회 소속 조사원 확인절차

a. 사진이 첨부된 소속기관의 신분증과 면허번호 등을 확인한다.

b. 추가진단전문의 관리 대장에 서명 날인하고, 입실시간과 퇴실시간을 적는다.

c. 관리대장은 개인정보보호를 위해 지정된 담당자(입원원무팀, 해당 병동 의료진)만 열람할 수 있으며 잠금장치가 있는 수납장에 보관한다.

d. 방문자의 신변보호를 위해 방문시간 중에는 보안요원이 병동 내 상주하도록 한다.

(5) 응급입원

① 자신 또는 타인을 해할 위험이 큰 자를 발견한 자는 그 상황이 매우 급박하여 정신건강복지법 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 입원등을 시킬 시간적 여유가 없을 때에는 의사와 경찰관의 동의를 얻어 응급입원이 가능하다.

② 3일(공휴일은 제외한다)의 범위 내에서 응급입원을 시킬 수 있고 정신건강의학과 전문의의 진단 결과 자신 또는 타인을 해할 위험으로 인하여 계속하여 입원할 필요가 있다고 인정될 때에는 정신건강복지법 제 41조부터 제 44조까지의

입원으로 전환할 수 있다. 응급입원을 하게 되면 보호의무자 또는 보호를 하고 있는 사람에게 입원 사유, 기간 및 장소를 서면 또는 전자문서로 통지한다.

③ 정신건강복지법 제50조제1항에 따라 응급입원을 의뢰하려는 사람은 응급입원 의뢰서에 의사와 경찰관의 동의서를 첨부하여 정신의료기관에 제출한다.

2) 입원 수속 절차

(1) 입원 유형별 법령에 따른 구비서류 확인

① 자의입원

a. 권리고지

b. 자의·동의입원등 신청서

c. 주민등록증 사본 또는 주민등록등본

② 동의입원

a. 권리고지

b. 자의·동의입원등 신청서

c. 환자의 주민등록증 사본 또는 주민등록등본1부

d. 보호의무자임을 확인할 수 있는 서류(주민등록등본, 가족관계증명서, 건강보험증 등)

③ 보호의무자에 의한 입원(보호입원)

a. 권리고지

b. 보호입원등 신청서

c. 환자의 주민등록증 사본 또는 주민등록등본 1부

d. 보호의무자임을 확인할 수 있는 서류(주민등록등본, 가족관계증명서, 건강보험증 등)

e. 진단 결과서가 포함된 입원등 권고서 1부

④ 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 의한 입원(행정입원)

a. 진단 결과서

b. 행정입원 의뢰서

⑤ 응급입원

a. 응급입원을 동의한 의사와 경찰관의 서명이 된 응급입원 의뢰서

(2) 진료비용 안내: 세브란스병원 내규 [2.1.2.1. 세브란스병원 이용 – 입원]에 따른다.

(3) 야간 및 휴일에 발생할 수 있는 입원 절차: 세브란스병원 내규 [2.1.2.1. 세브란스병원 이용 – 입원]에 따른다.

3) 입원 시 제공되는 정보

(1) 입원생활 안내: 세브란스병원 내규 [2.1.2.1. 세브란스병원 이용 – 입원]에 따른다.

(2) 권리구제 안내: 입원 시 환자 및 보호의무자에게 권리구제(정신건강심사위원회 퇴원 등 처우개선 심사청구, 법원 인신보호 구제청구, 국가인권위원회 진정)에 대해 안내한다.

4) 계속입원 절차

(1) 자의입원 및 동의입원에 의해 입원한 환자는 2개월마다 퇴원할 의사가 있는지 여부를 환자에게 확인하여야 한다.

(2) 보호의무자에 의한 입원기간은 입원기간 만료일 전 2개월이 되는 날부터 입원기간

만료일 전 1개월이 되는 날까지의 기간 내에 지자체장에게 연장심사를 청구해야 한다.

① 1차 입원 기간 연장 이후의 입원 기간 연장: 입원일 기준으로 3개월 → 3개월 → 6개월 → 6개월 주기로 입원기간 연장심사를 할 수 있다.

② 정신의료기관의 장은 다음의 모두에 해당하는 경우에만 입원 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 정신의료기관의 장은 입원등 기간을 연장할 때마다 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에게 대통령령으로 정하는 기간 이내에 그 연장에 대한 심사를 청구하여야 한다.

a. 서로 다른 정신의료기관등에 소속된 2명 이상의 정신건강의학과 전문의가 입원 기간을 연장하여 치료할 필요가 있다고 일치된 진단을 하는 경우

b. 보호의무자 1명 이상(입원 신청 시 보호의무자가 1명만 있었던 경우에는 1명으로 한다)이 입원 기간 연장에 대한 동의서를 제출한 경우

c. 입원기간 연장 청구 구비서류: 입원연장심사 청구서, 국립정신병원장에게 입원기간을 연장하여 치료가 필요하다고 받은 통지, 보호의무자 2명의 입원기간 연장에 동의한다는 서류, 보호의무자 변동이 있는 경우의 보호의무자 변동서류

(3) 입원 기간을 연장하였을 때에는 지체 없이 환자 및 보호의무자(보호의무자에 의한 입원의 경우)에게 그 사실 및 사유를 서면으로 통지하여야 한다.

5) 타 기관 소속직원 방문에 대한 응대 절차

(1) 사진이 첨부된 소속기관의 신분증과 면허번호 등을 확인한다.

(2) 추가진단전문의 관리 대장에 서명 날인하고, 입실시간과 퇴실시간을 적는다.

(3) 관리대장은 개인정보보호를 위해 지정된 담당자(입원원무팀, 해당 병동 의료진)만 열람할 수 있으며 잠금장치가 있는 수납장에 보관한다.

(4) 방문자의 신변보호를 위해 방문시간 중에는 보안요원이 병동 내 상주하도록 한다.

4. 퇴원 절차

1) 퇴원계획 수립: 입원기간 동안 초기평가 및 재평가 과정에 포함되며 입원유형별 퇴원절차, 환자의 의학적 상태에 대한 정신건강의학과 전문의 소견에 따라 환자의 퇴원 여부를 결정한다.

2) 퇴원 시 환자교육: 세브란스병원 내규 [2.1.5.1. 퇴원]에 따른다.

3) 퇴원요약 정보 제공 세브란스병원 내규 [2.1.5.1. 퇴원]에 따른다.

4) 입원유형별 퇴원절차

(1) 자의입원: 환자가 퇴원 신청을 하면 퇴원이 가능하며, 환자에게 2개월마다 퇴원 의사 여부를 확인한다.

(2) 동의입원

① 환자가 퇴원 신청을 하면 퇴원이 가능하며, 환자에게 2개월마다 퇴원 의사 여부를 확인한다. 다만, 정신질환자가 보호의무자의 동의를 받지 아니하고 퇴원을 신청한 경우에는 정신건강의학과 전문의 진단 결과 환자의 치료와 보호 필요성이 있다고 인정되는 경우에 한정하여 정신의료기관의 장은 퇴원의 신청을 받은 때부터 72시간까지 퇴원을 거부할 수 있고, 퇴원을 거부하는 기간 동안 보호의무자에 의한 입원 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 의한

입원으로 전환할 수 있다.

② 정신의료기관의 장은 동의입원 환자의 퇴원을 거부하는 경우에는 지체 없이 환자 및 보호의무자에게 그 거부 사유 및 퇴원의 심사를 청구할 수 있음을 서면 또는 전자문서로 통지하여야 한다.

(3) 보호의무자에 의한 입원

① 환자 또는 입원신청서를 제출한 보호의무자가 퇴원 신청을 하면 정신건강의학과 전문의가 퇴원 여부를 결정한다.

② 정신의료기관의 장은 보호의무자에 의한 입원을 한 환자 또는 보호의무자가 퇴원을 신청한 경우에는 지체 없이 그 사람을 퇴원을 시켜야 한다. 다만, 정신의료기관의 장은 그 입원을 한 사람이 정신의료기관에서 입원치료 또는 요양을 받을 만한 정도 또는 성질의 정신질환을 앓고 있는 경우이면서 환자 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있어 입원을 할 필요가 있는 경우 모두 해당하는 경우에는 퇴원을 거부할 수 있다.

③ 정신의료기관의 장은 퇴원을 거부하는 경우에는 지체 없이 정신질환자 본인과 퇴원을 신청한 보호의무자에게 그 거부사실 및 사유와 퇴원의 심사를 청구할 수 있다는 사실 및 그 청구 절차를 서면으로 통지하여야 한다.

(4) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 의한 입원(행정입원): 정신건강의학과 전문의가 환자의 상태에 따라 퇴원 여부를 결정한다.

(5) 응급입원: 정신건강의학과 전문의가 환자가 계속하여 입원할 필요가 없다고 인정된 경우에는 즉시 퇴원시켜야 한다.

5) 퇴원사실에 대하여 해당 관할 정신건강복지센터 또는 관할 보건소에 통지하는 것에 대한 환자(정신건강의학과 전문의가 환자 본인의 의사능력이 미흡하다고 판단하는 경우 보호의무자)의 동의여부에 대해 확인하고 퇴원 사실 통보서에 동의를 받아 관할 정신건강복지센터의 장 또는 보건소의 장(관할 지역에 정신건강복지센터가 없는 경우만 해당한다)에게 통보하도록 한다.

5. 통신 및 면회 제한

1) 통신과 면회는 제한하지 않으며 치료적으로 필요한 경우 다음 사항을 준수한다.

2) 통신 및 면회제한의 시행 기준

(1) 환자의 통신 및 면회 제한은 시행 전 반드시 정신건강의학과 전문의와 상의하고, 지시에 따라 치료적 목적으로 시행해야 한다.

3) 통신 및 면회 제한 시 사유, 내용, 제한 당시 환자의 병명, 증상, 시행 시간, 지시자/수행자, 등을 환자 및 보호자에게 설명하고 기록한다.

4) 통신 및 면회 제한 중 환자가 외부에 연락을 해야 할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 정신건강의학과 전문의의 확인 하에 통신 및 면회 제한 해제 혹은 병동 내 유선 전화를 사용할 수 있도록 한다.

5) 정신건강의학과 전문의가 통신 및 면회 제한 해제를 결정하면 해당 사항에 대해 환자 및 보호자에게 설명하고 통신 및 면회 제한의 해지 사유와 내용, 지시자/수행자, 해지 시간을 기록한다.

6. 치료프로그램

1) 치료 프로그램은 정신건강의학과 전문의의 지시 하에 시행되며 환자에게 적합한 프로그램을 운영하고 가능한 프로그램에 참여하도록 한다.

2) 인지행동치료

(1) 목적: 환자의 증상 경감과 적응 기능의 향상을 통해 장기간 치료 효과가 유지되도록 하며 재발을 최소화하기 위함이다.

(2) 구성: 정신건강의학과/소아정신과 외래 또는 입원 환자 중에서 치료 프로그램 참여를 원하는 환자 2인 이상

(3) 시행자: 프로그램 수행 자격은 전문의 임상권한, 전공의 직무기술서에 따른다.

(4) 참여 대상: 참여 의사 및 동기가 있는 모든 환자

(5) 제외 대상: 질환이 급성기 상태에 있거나 자신이나 타인을 해할 위험이 있는 상태의 환자

(6) 일정: 치료 프로그램 세션은 주 1회, 세션 당 1시간으로 진행되며, 치료에 따라5~10회 시행되며 단, 환자2인 이상이 참여한 치료 그룹이 구성된 경우에만 진행된다.

(7) 장소: 병동 내 집단 치료실 및 면담실, 혹은 외래 진료실

(8) 결과 기록: 정신건강의학과 전문의의 지시 하에 치료프로그램을 시행한 자가 매 세션마다 치료프로그램의 내용과 결과, 지시자와 수행자 및 실시일시가 포함된 치료수행 기록을 남긴다.

(9) 피드백: 시행자는 매 세션마다 대상 환자와 보호의무자에게 프로그램 효과와 요구사항에 대한 피드백을 받고, 이를 시행 결과 기록에 포함시킨다. 또한 시행자는 시행 결과 기록을 공유하여 정신건강의학과 전문의로부터 프로그램 전반에 대한 피드백을 받아 프로그램을 개선한다.

(10) 매뉴얼: 조현병(전임홍, 이수영, 선자연 외, 『조현인지치료 전문가 메뉴얼』 (학지사, 2013)), 수면장애 (잭 D. 에딩거, 콜린 E. 카니, 『불면증 약 없이 극복하기 치료자용 가이드북』, 이은 역 (청년의사, 2010)) 등 질환군에 따른 적절한 인지행동치료 매뉴얼에 따라 치료 프로그램을 시행한다.

3) 사회기술훈련

(1) 목적: 환자의 효과적인 상호작용 기술, 다양한 상황에 대처하는 능력을 향상시켜 학교 및 일상생활에서 적응을 돕기 위함이다.

(2) 구성: 소아정신과 외래 환자 중에서 치료 프로그램 참여를 원하는 환자 2인 이상

(3) 시행자: 정신건강의학과 의사 및 정신보건 전문요원

(4) 참여 대상: 사회적 의사소통의 문제와 대인관계 기술의 결핍이 있는 환자

(5) 제외 대상: 질환이 급성기 상태에 있거나 자신이나 타인을 해할 위험이 있는 상태의 환자

(6) 일정: 주 1회, 세션 당 60~90분 (부모교육 시간 별도 30분) 내외로 총 8~12회가 시행되며 단, 환자 2인 이상이 참여한 치료 그룹이 구성된 경우에만 진행된다.

(7) 장소: 병동 내 집단 치료실 및 면담실, 혹은 외래 진료실

(8) 결과 기록: 정신건강의학과 전문의의 지시 하에 치료 프로그램을 시행한 자가 매 세션마다 치료프로그램의 내용과 결과, 지시자와 수행자 및 실시일시가 포함된 치료수행 기록을 남긴다.

(9) 피드백: 시행자는 매 세션마다 대상 환자와 보호의무자에게 치료 프로그램의 효과와 요구사항에 대한 피드백을 받고, 이를 치료 프로그램 시행 결과 기록에 포함시킨다. 또한 시행자는 치료 프로그램 시행 결과 기록을 공유하여 정신건강의학과 전문의로부터 치료 프로그램 전반에 대한 피드백을 받아 치료 프로그램을 개선한다.

(10) 매뉴얼: 의사소통 기술훈련 매뉴얼, 문제해결 기술훈련 매뉴얼 등 내부 매뉴얼에 따라 치료 프로그램을 시행한다.

7. 소아청소년 환자의 입원치료

1) 소아, 청소년은 보호를 필요로 하므로 입원은 기본적으로 신중하게 결정되어야 하며, 다음의 경우, 입원을 통해 치료상 장점을 도모할 수 있다.

(1) 정신병적 증상으로 인한 위험으로부터 환자 자신과 타인을 보호하고자 하는 경우

(2) 입원치료를 통해 환자의 임상 상태를 정확하게 평가하기 위하여 통제된 환경에서의 행동, 정서 반응, 생활기능 및 치료자와의 관계를 관찰하고자 하는 경우

(3) 입원 환경이 환자에게 보다 나은 안정감과 집중적인 치료효과 및 발달 증진을 제공할 수 있는 경우

2) 입원 기준

(1) 자해 및 타해의 위험이 있고 가정, 학교의 기능만으로는 이를 충분히 보호할 수 없는 경우(자해 및 타해란 자살사고, 자살계획, 자살시도, 공격적 위협, 난폭한 행동 등을 지칭한다.)

(2) 사고, 행동, 정동의 양상이 매우 비합리적이고 기괴하여 일상생활에 현저한 장애를 초래, 통상적인 외래 치료가 불가능한 경우

(3) 치료가 꼭 필요하나 환자의 협조능력이 떨어져 반복적인 격리, 강박이 필요한 경우

(4) 심각한 섭식 장애 등 집중적인 내과적 치료 보조가 필요한 경우

(5) 품행에 문제가 있어 반복될 위험성이 높은 경우(가출, 방화, 성문란 등)

(6) 비합법적인 물질(마약, 술 등) 사용의 위험성이 높은 경우

(7) 발달장애의 정밀 평가, 정신 감정 등 의학적 및 법률적 진단과 평가를 위해 지속적이고 숙련된 관찰이 필요한 경우

(8) 환자 가족 및 환경의 문제가 질환의 발생과 유지에 영향을 미치고 있어 이에 대한 적극적인 개입이 필요한 경우

(9) 정신과적 증상으로 인하여 환자 자신의 안정에 심각한 위협이 되는 상황인 경우

(10) 빠른 약물조절이 필요하거나 약물 부작용이 우려되어 집중적 관찰 및 치료가 필요한 경우

3) 환자가 대화가 가능한 수준이라면 환자에게 입원 필요성을 알리고, 법정대리인의 서면 동의를 얻어 입원을 결정한다.

4) 입원치료를 통하여 환자의 증상 개선과 아울러 적절한 정상발달상의 특성을 회복하는지를 면밀하게 관찰하여야 한다.

8. 환자권리 존중

1) 환자의 권익보호를 위해 입원 및 퇴원 시 다음의 사항 안내

(1) 입원 시 권리고지 및 확인서를 통한 입원유형 및 입원 유형에 따른 퇴원방식, 강제

동의 입원 금지 및 강제 동의 입원 환자의 퇴원신청 방법 (정신건강심사위원회 퇴원 등 처우개선 심사청구, 국가인권위원회에 진정 신청, 법원에 퇴원을 위한 인신구제 청구), 강제 동의 입원환자에 대한 입원 필요성 검토 절차 안내

(2) 병원외의 장소에 수용금지, 입원 환자에 대한 폭행 및 가혹행위를 금지 등

2) 통신 및 면회 제한에 관한 사항 준수

(1) 정신건강의학과, 소아정신과 환자의 통신 및 면회의 자유 제한을 금지한다.

(2) 단, 치료 목적으로 전문의의 지시에 따라 최소한의 범위 내에서만 통신 및 면회의 자유를 제한할 수 있다.

(3) 통신 및 면회의 자유를 제한할 시 제한의 사유 및 내용, 제한 당시의 환자의 병명 및 증상, 제한의 개시 및 종료시간, 제한의 지시자 및 수행자를 의무기록에 기록해야 한다.

(4) 환자가 외부에 연락을 해야 할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 정신건강의학과, 소아정신과 전문의의 확인 하에 통신 및 면회 제한 해제 또는 병동 내 유선 전화를 사용할 수 있도록 한다.

3) 강제 노역 금지: 입원환자에게 정신건강의학과, 소아정신과 전문의의 지시에 따른 치료 또는 재활의 목적이 아닌 노동을 강요하여서는 안된다.

4) 국가인권위원회 진정에 관한 사항 고지

(1) 최초 입원 시, 환자에게 인권침해 사실을 위원회에 진정할 수 있다는 뜻과 그 방법을 고지하여야 한다.

(2) 인권침해에 관하여 위원회에 진정할 수 있다는 뜻과 그 방법을 기재한 안내서를 상시로 열람할 수 있는 곳에 비치하여야 한다.

(3) 의료기관은 병동 내 진정함을 설치하고, 용지 필기도구 및 봉함용 봉투를 비치하고, 접수 대장을 관리한다.

5) 개인물품 관리

(1) 입원환자는 환자별 사물함을 제공받고, 병원은 입원 시 및 주 1회 정기적으로 사물함을 관리한다.

6) 치료적 목적의 녹음, 녹화, 촬영은 환자 또는 보호자의 동의를 받고 실시하며, CCTV 설치 장소를 환자 또는 보호자에게 안내한다.

7) 정신건강의학과 보호병동에서는 환자의 상태 관찰 및 위험상황 시 신속한 대처를 위해 휴게실, 면담실, 안정실, 안정실 내 화장실 등의 공용공간과 1인실 중 3개의 병실에 CCTV를 설치 운영하며, 안정실 내 화장실의 경우 환자의 사생활을 최대한 보호하기 위해 머리부위 외에 다른 신체노출 부위는 촬영하지 않는다.

8) 격리 및 강박을 시행할 경우 세브란스병원 내규 [3.2.5.2. 정신건강의학과 격리 및 강박]에 따라 적용 및 해지한다.

9. 환자의 의무: 정신건강의학과, 소아정신과에 입원하는 환자 또는 보호의무자는 입원 시 관련 서류 작성 및 제출, 병동 내 위해도구 반입 금지 등에 협조해야 한다.

10. 직원교육: 정신건강의학과/소아정신과 관련 직원은 인권교육을 매년 4시간 이상 이수한다.

제4조 (부록)

1. 병동 내 위해도구 점검일지
2. 환자 및 보호자 물품 검사 현황
3. 자살의 위험성 평가(SSS, Severance Suicide Scale)
4. 자해의 위험성 평가(SDSHS, Severance Deliberate Self Harm Scale)

제5조 (참고)

1. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률
2. 보건복지부 정신건강복지법에 따른 입.퇴원절차 안내

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)